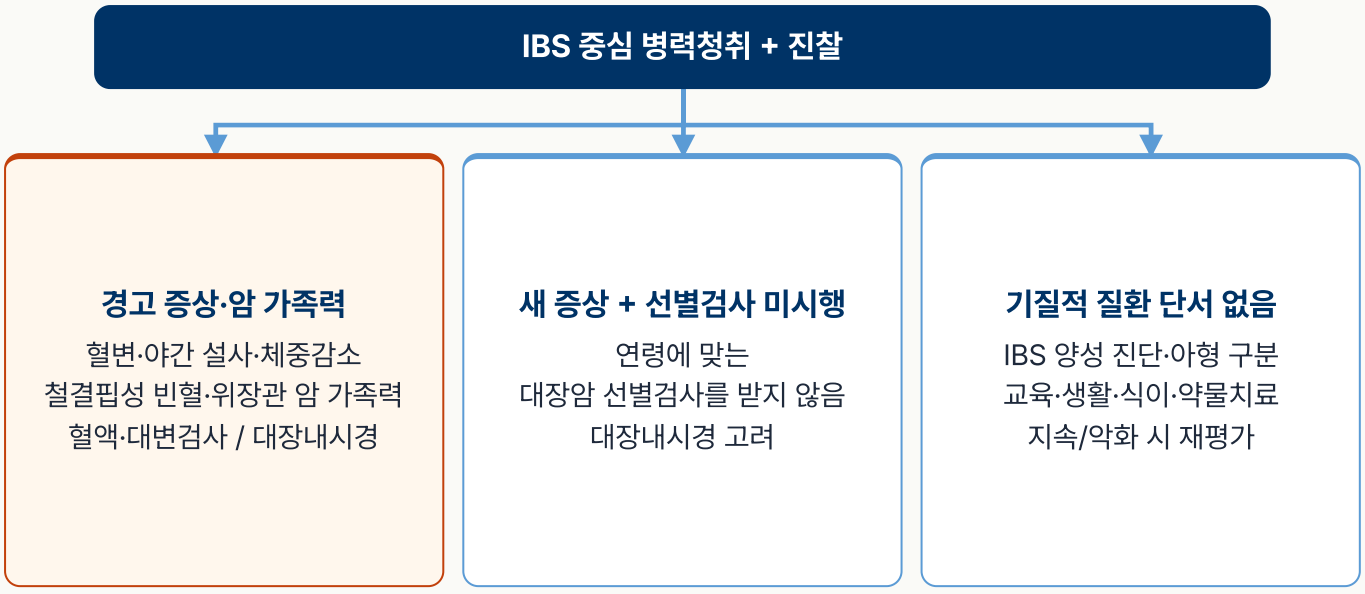
성인 IBS 초진·치료 실패 시 검사와 의뢰 선택표

양성 진단(positive diagnosis)을 기본으로, 경고 증상과 치료 반응에 따라 검사를 고릅니다.

초진에서 먼저 나누는 검사 경로



일률적 검사 확대 대신 기질적 질환을 시사하는 단서를 찾습니다.

병력에서 빠뜨리지 않을 항목

01 시작 시점·지속 기간, 이전 위장관 감염·항생제, 스트레스·심리적 외상.

02 복통과 배변 습관 변화의 관계, 장외 증상·다른 기능성 질환·동반 질환.

03 Opioid를 포함한 복용약: 약제 관련 변비를 IBS-C로 오인하지 않도록 구분.

강의의 Rome V와 국내 지침을 구분

검사	강의의 적용 맥락
CBC · CRP · celiac serology	Rome V의 기본 검사. Celiac은 특히 IBS-D에서 고려하되 국내 빈도가 낮다는 연자 설명을 함께 적용.
ESR · CRP · 대변 calprotectin	국내 KSNM: 경고 증상에서 IBD 감별. Rome V는 ESR을 일상검사로 권하지 않는다는 차이를 명시.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

성인 IBS 초진·치료 실패 시 검사와 의뢰 선택표

상세 확인 · 질환별 적용과 안전성

선택검사와 기능검사

상황	선택
증상·연령·위험인자에 따라	TSH, CMP, 대변 calprotectin, Giardia antigen, 장관 병원체·선택적 대변검사.
만성 설사·IBS-D 의심	담즙산 흡수장애(BAM) 평가. 강의 당시 국내에는 검사 키트가 없다는 설명.
배변장애 의심	직장수지검사 이상, 과도한 힘주기, 배변 곤란·잔변감, 손가락 관장 → ARM ± 풍선배출검사. 바이오피드백 대상 선별.

일상적으로 시행하지 않는 검사

맥락	검사
경고 증상 없는 IBS · Rome V	SIBO 호기검사, stool O&P, ESR, 복부 CT, 대장내시경, anti-vinculin antibody.
국내 지침	모든 IBS 환자에게 장관 병원체 검사·분변잠혈검사를 일률적으로 시행하지 않음.

적절한 치료에도 지속·악화되면

01 진단과 우세 증상을 다시 평가합니다. 경고 증상·대장암 선별검사 이력을 재확인합니다.

02 혈액검사·대장내시경 또는 배변장애에 맞는 항문직장내압검사를 선택합니다.

03 기질적 질환이 확인되면 해당 질환 치료로 전환합니다. 검사·치료 반응에 맞춰 진료를 이어갑니다.

04 그래도 호전이 없으면 TCA 등 신경조절제를 고려합니다.

강의에서 소개한 진단 기준

최근 3개월 평균 월 3일 이상, 지속적이지 않고 반복되는 복통 또는 복부 불편감. 배변 관련·배변 횟수 변화·대변 형태 변화 중 ≥2개와 관련. 증상은 최소 6개월 이전 시작. 지속적인 복통과 월경 때만 생기는 증상은 구분합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 과민성 장증후군의 진단과 맞춤 치료(정기욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-ibs-evaluation-referral/